EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL	: HOSPITAL DE SAN CARLOS	N° EGRESO	: 83599
SERVICIO	: UNIDAD EMERGENCIAS		
FECHA	: 2024-04-30 18:37:05		

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: NOLFA ELIZABETH MERINO VASQUEZ			**RUN**	: 14.304.297-9
F.Nac	: 31-07-1975	**Edad**	: 48 AÑOS, 8 MESES	**Género**	: Femenino
Dirección	: SAN PEDRO DE LILAHUE			**Comuna**	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA D	**Teléfono**	: 87534551		
Fecha Ingreso	: 29-04-2024	**Fecha Egreso**	: 2024-04-30 18:37:05	**Causal**	: MEDICA
Condición	: VIVO	**Destino**	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	**Derivación**	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Sepsis en tratamiento ¿origen urinario?
Infección del tracto urinario alta. Pielonefritis aguda.
Diabetes mellitus tipo 2 descompensada.
Hipertensión arterial crónica.
Psoriasis.

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. A41.9-SEPTICEMIA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Antecedentes:
- DM2, HTA, psoriasis.
- Alergia a ibuprofeno y ketoprofeno.
- Cirugías previas: apendicectomía, colecistectomía, cesárea.
- Hospitalización en abril 2022 por shock cardiogénico, TEP bilateral, ITU por E. coli, obs. absceso renal izquierdo, insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, DM2 descompensada, AKI prerrenal.

.

Paciente de 48 años con antecedentes de DM2, HTA y psoriasis, que ingresa por cuadro de 8 días de evolución caracterizado por cefalea holocránea intensa, astenia, compromiso del estado general, fiebre intermitente, diarrea, náuseas, mareos y vómitos. Al ingreso destaca febril, taquicárdica, normotensa, con puño percusión lumbar derecha positiva. Se sospecha pielonefritis aguda, iniciándose tratamiento antibiótico empírico con Ceftriaxona. Se solicita urocultivo y cultivo de LCR, ambos pendientes al momento del alta.

.

Durante hospitalización evoluciona favorablemente, con resolución de la cefalea y sin nuevos episodios de fiebre. No presenta compromiso hemodinámico. En exámenes destaca discreta leucocitosis y PCR en ascenso hasta 361 mg/L. Procalcitonina 1.9 ng/mL. LCR no impresiona con características de meningitis.

.

Considerando la evolución clínica satisfactoria, por indicación de comisión de eficiencia hospitalaria y jefatura de servicio, se decide alta precoz para continuar manejo con hospitalización domiciliaria.

INDICACIONES AL ALTA

1. - Hospitalización domiciliario
2. - Ceftriaxona 2 gr EV c/24 hrs por al menos 7 días. Completar tratamiento con hospitalización domiciliaria.
3. - Reevaluar según resultados de urocultivo y cultivo LCR. Considerar cambio a terapia oral según antibiograma.
4. - Régimen liviano hipoglicémico.
5. - Control HGT precomida. Objetivo HGT < 180 mg/dL.
6. - Insulina NPH 30 UI AM y 28 UI PM. Ajustar según HGT.
7. - Insulina cristalina según esquema de corrección
8. - Paracetamol 500 mg 2 comp VO c/8 hrs SOS T>38°C o dolor.
9. - Metoclopramida 10 mg EV c/8 hrs SOS náuseas o vómitos.
10. - Omeprazol 20 mg VO c/24 hrs.
11. - Control medico con exs de control Hemograma, PCR, procalcitonina y función renal en 48 hrs.
12. - Urocultivo y cultivo LCR de control.
13. - Evaluacion en urgencia en caso de evolución desfavorable

Félix Sanhueza Luna
MEDICO TRATANTE
14542245-0

JEFE SERVICIO